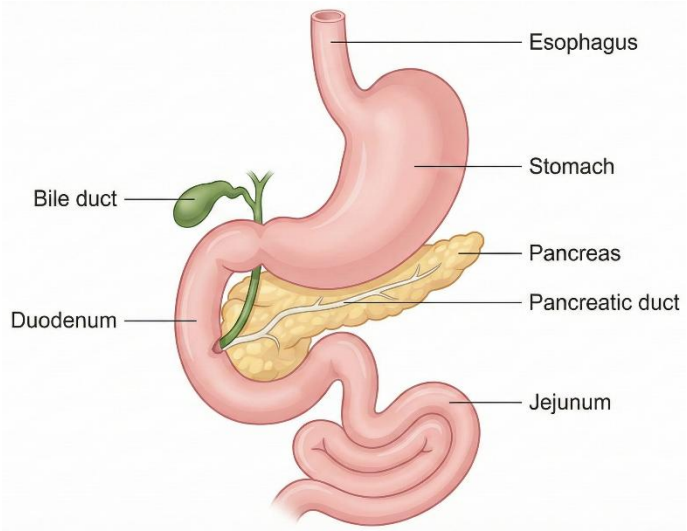
GASTRECTOMÍA

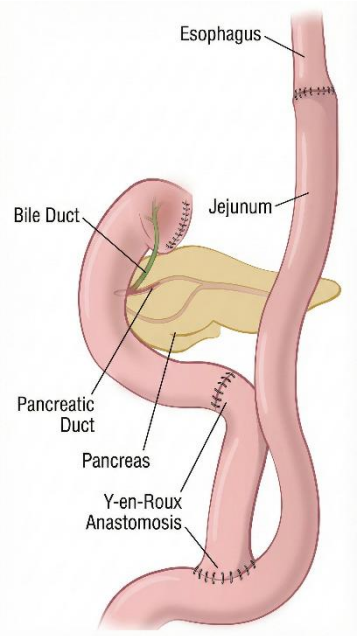
Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Mª Elba Palomares Ramos, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

GASTRECTOMÍA TOTAL

El cáncer gástrico presenta un pronóstico desfavorable, siendo el tratamiento quirúrgico el eje fundamental de su tratamiento. La gastrectomía total es el procedimiento de elección en neoplasias gástricas localizadas en cuerpo o estómago proximal. En combinación con la linfadenectomía D2, que comprende la extirpación de los ganglios perigástricos y aquellos adyacentes a las ramas del tronco celíaco (arteria hepática, esplénica y arteria gástrica izquierda) permite disminuir el riesgo de recidiva loco-regional.

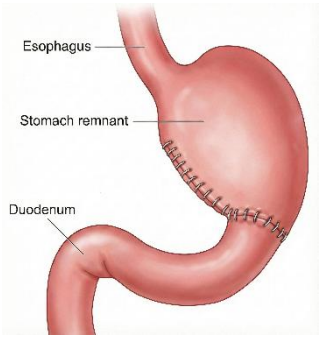




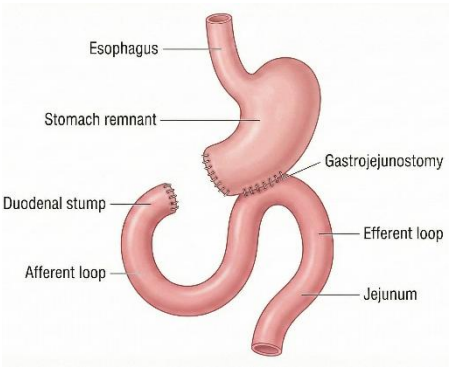
GASTRECTOMÍA SUBTOTAL

La técnica es básicamente la misma, pero se respeta una parte del estómago dependiendo de la localización del tumor. Si la resección es distal colocaremos el trocar por debajo del ombligo. Si es más cefálica se pone el trocar por encima.

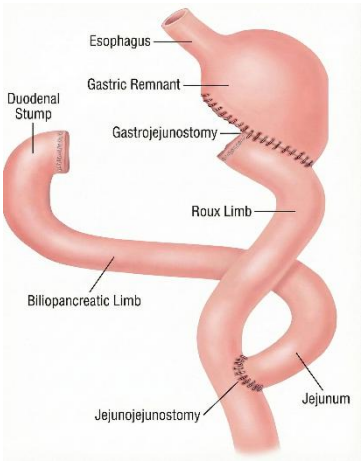
Para la reconstrucción del tránsito intestinal, dependiendo de las preferencias del cirujano, de las características del paciente y del tipo de resección realizada, se realizará una reconstrucción tipo Billroth 1, Billroth 2 o una Y de roux, también conocido como Billroth 3.



Billroth 1



Billroth 2



Billroth 3

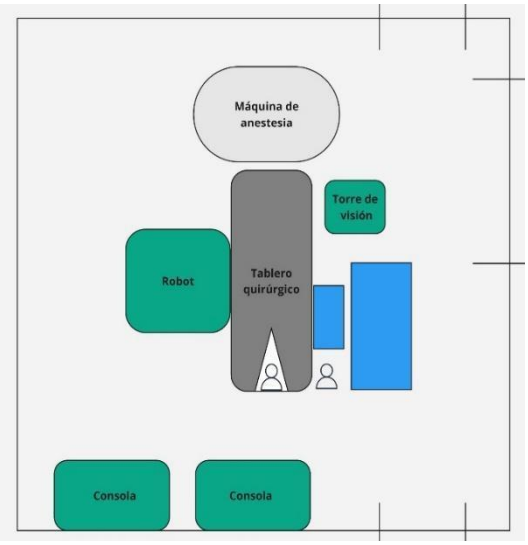
POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Brazos alineados con el cuerpo.
- Decúbito supino.
- Perneras bajas. Importante reforzar con foam la parte superior de ambas rodillas para tener una protección extra en caso de que los brazos del robot hagan contacto.



POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

- Anatomía: abdominal
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-up / Prograsp
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Endoscopio 30°
  - Brazo 4: Harmonic
- Tablero quirúrgico:
  - Anti-trendelemburg 12°
  - Piernas con ligera elevación

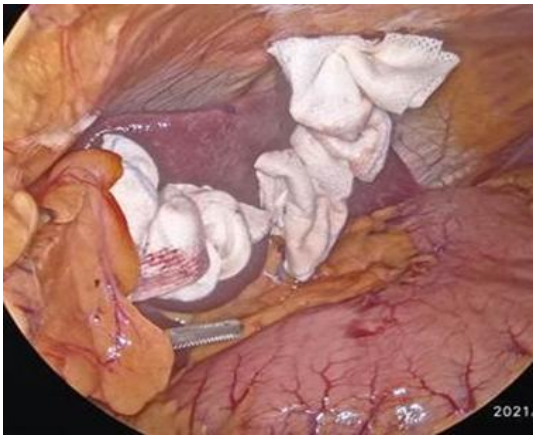


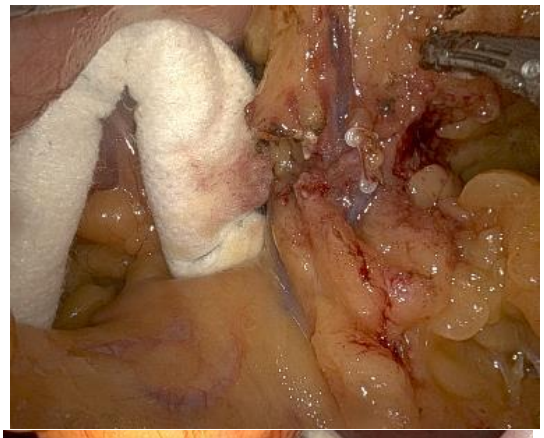
TÉCNICA QUIRÚRGICA

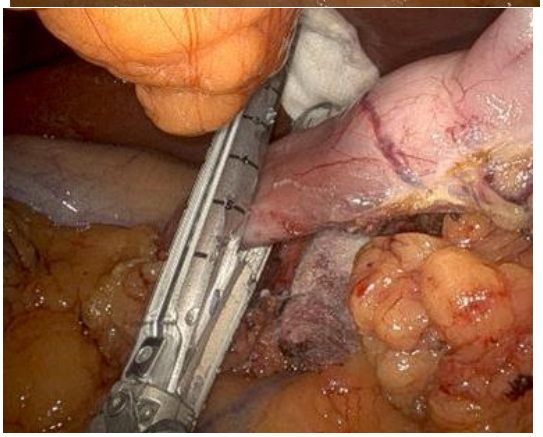
- Preparación de campo y colocación de trócares.
- Desde el inicio, se deja colocada a unos 30 cm de la comisura bucal, la sonda de calibración gástrica de 38ch que será necesaria durante la cirugía.



- Revisión de la cavidad y liberación de adherencias.
- Una forma de elección, para separar el hígado, podría ser la colocación de dos gasas plegadas en acordeón y atravesadas por un hilo que se fija en la membrana del ligamento hepato-gástrico con hem-o-lok, y se sujeta externamente con ayuda de un pasahilos y dos pinzas tipo crile.



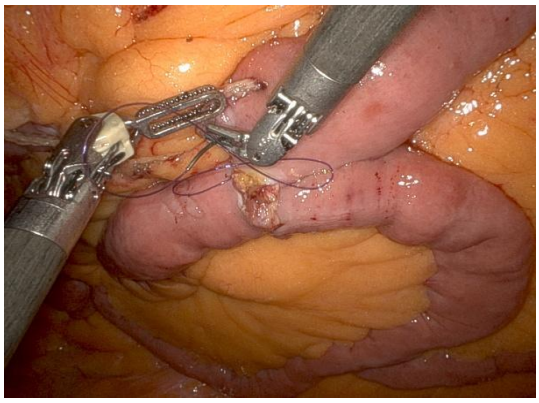




- Disección de estructuras hasta liberar la curvatura mayor desde el píloro hasta el cardias, seccionando la arteria pilórica, los vasos gastroepiploicos y otras pequeñas ramas.
- Disección de la curvatura menor del estómago hasta llegar al duodeno.
- Se realiza la linfadenectomía que generalmente es la conocida como D2 y que incluye los ganglios paracardiales, los de la curvatura mayor y menor, los supra e infrapilóricos, los que rodean la arteria gástrica izquierda, hepática común, tronco celiaco, hilio esplénico, arteria esplénica y ligamento hepatoduodenal.
- Se secciona la unión gastroduodenal con endograpadora con carga de 45 intestinal azul.
- Si la gastrectomía es total, se necesita la movilización de la sonda de calibración previo a la sección de la unión gastroesofágica.
- Sección de la parte proximal del estómago con endograpadora mecánica y cargas generalmente azules.
- Se procede al embolsado el estómago resecado.
- Se comprueba la vascularización de las zonas a anastomosar con verde de indocianina.
- La reconstrucción se puede realizar según técnica de Billroth 1, 2 o la Y de Roux. La diferencia entre estos tipos de reconstrucción está en el segmento de intestino delgado que se emplea. Así, en el Billroth I la anastomosis es con el duodeno mientras que, en el Billroth II y en la Y de Roux, la continuidad del tránsito se establece con el yeyuno. En la primera se sube un asa de yeyuno en forma de omega. En cambio, en la Y de Roux el yeyuno se secciona completamente para subir el asa eferente y hacer la anastomosis con el remanente gástrico o con el esófago,

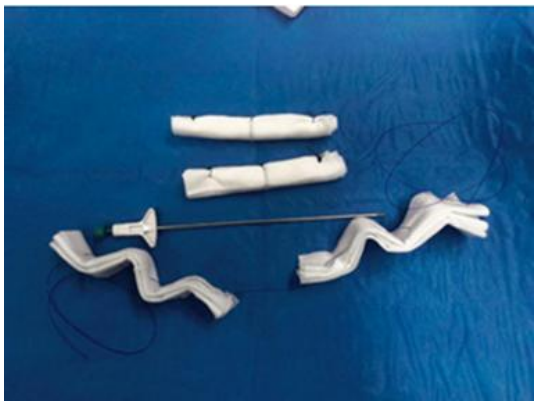
según el tipo de gastrectomía realizado. Esta última técnica de reconstrucción es la más ampliamente usada, por lo que es la que explicaremos.

- La primera anastomosis es para la reconstrucción del tránsito. Para ello, el yeyuno se secciona a unos 20 o 30 cm del ángulo duodenoyeyunal, donde el meso es más largo y tiene más movilidad para permitir el ascenso del asa distal.
- Se realiza la anastomosis esófago-yeyunal con la técnica de asa en Y de Roux, con sutura mecánica, la misma que se usó previamente. Aquí se realiza apertura en esófago y se saca la sonda, que se usará como guía para la pala de la grapadora que entra al esófago en un movimiento conjunto por parte del cirujano de campo y del enfermero que irá retirando la sonda.
- Se cierra con sutura tipo monocryl 3-0 el orificio de entrada de la grapadora.
- La siguiente anastomosis es la yeyuno-yeyunal, a unos 60-70 cm de la primera sección del yeyuno. Se repite el mismo procedimiento de anastomosis usado anteriormente.



- Para comprobar que no hay fugas tras hacer la anastomosis, se prepara azul de metileno en una jeringa de 50 ml de alimentación y se introducen 100-120 ml para comprobar que no exista pérdida del suero en la línea de grapas y sutura.
- Colocación de drenaje con aspiración de baja presión. Puede utilizarse algún hemostático o sellante, tipo Tachosil, sobre lecho pancreático de la linfadenectomía y del muñón duodenal.
- Comprobación de hemostasia y cierre de heridas.

NOTAS



- Cuando empiece la cirugía hay que tener preparado un sistema de retracción hepático. Se hace con una gasa pequeña abierta a lo largo y plegada en forma de acordeón, unida a otra gasa igual, y enhebradas las dos con una sutura del 0 monofilamento.
- Tener preparados varios cilindros de 1 gasa (QuirPad).
- El corte y coagulación ultrasónica puede ser la técnica de elección. En este caso, tener preparada la consola adecuada.
- Si se hacen anastomosis manuales, la técnica es termino-lateral con dos monocryl 3-0 a 15 cm y a 20 cm. También se usa seda de 2-0 de 20 cm y loop al final para cerrar el meso.

BIBLIOGRAFÍA

1. Salvador-Rosés H, Escartín A, Muriel P, Santamaría M, González M, Jara J, et al. ROBOTIC VERSUS OPEN APPROACH IN TOTAL GASTRECTOMY FOR GASTRIC CANCER: A COMPARATIVE SINGLE-CENTER STUDY OF PERIOPERATIVE OUTCOMES. J Robot Sur. 2023; 17(4): 1735–41. Available from: https://link.springer.com/article/10.1007/s11701-023-01591-1